

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

ร่างโครงการ

พัฒนาและนำระบบ LawiRisk-SSK Evidence Intelligence มาใช้ในการสืบสวน วิเคราะห์ความเชื่อมโยง และบริหารจัดการพยานหลักฐานดิจิทัล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

หมายเหตุ: ข้อความที่ขีดเส้นใต้เป็นข้อความที่เสนอให้เพิ่มหรือแก้ไขจากร่างเดิม

1. ชื่อโครงการ

โครงการพัฒนาและนำระบบ LawiRisk-SSK Evidence Intelligence มาใช้ในการสืบสวน วิเคราะห์ความเชื่อมโยง และบริหารจัดการพยานหลักฐานดิจิทัล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2. หลักการและเหตุผล

จากสถานการณ์เรื่องร้องเรียนด้านผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพในปัจจุบัน พบว่ามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับอาหาร อาหารเสริม ยา เครื่องสำอาง สถานพยาบาล คลินิก และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประกอบกับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการผ่านช่องทางออนไลน์ทำให้รูปแบบการกระทำผิดมีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

จังหวัดศรีสะเกษมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพไม่น้อยกว่า 50 เรื่องต่อปี ขณะที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับผิดชอบงานกฎหมายและการดำเนินคดีมีอัตรากำลังไม่สอดคล้องกับภาระงาน การตรวจสอบพยานหลักฐานดิจิทัลในแต่ละเรื่องต้องใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ 5-8 ชั่วโมง และข้อมูลสำคัญกระจายอยู่ในหลายรูปแบบ เช่น ภาพหน้าจอ URL หมายเลขโทรศัพท์ บัญชีธนาคาร ที่อยู่จัดส่ง เพจหรือบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ และเอกสารประกอบคดี

ผู้กระทำความผิดอาจสร้างเครือข่ายเพจหรือบัญชีอวดต้อ ใช้ชื่อหน้าร้านหลายชื่อ และเปลี่ยนช่องทางติดต่อเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ แม้หน้าร้านจะแตกต่างกัน แต่เบื้องหลังอาจมีจุดเชื่อมโยงร่วมกัน การตรวจสอบด้วยวิธีเดิมจึงใช้เวลามากและยากต่อการเชื่อมโยงข้อมูลข้ามเรื่องร้องเรียนหรือคดีในอดีต

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษจึงได้พัฒนา LawiRisk-SSK Evidence Intelligence เป็นระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานสืบสวนและบริหารจัดการพยานหลักฐานดิจิทัล โดยมุ่งเน้นการรักษาความสมบูรณ์ของหลักฐาน การบันทึกแหล่งที่มาและประวัติการครอบครองหลักฐาน การจำกัดสิทธิการเข้าถึงรายคดี การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงที่ตรวจสอบย้อนกลับได้ และการช่วยจัดทำร่างเอกสารทางกฎหมาย

ระบบดังกล่าวเป็นเพียงเครื่องมือสนับสนุนการวิเคราะห์ มิได้ใช้ตัดสินข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย ความผิด หรือผลทางคดีโดยอัตโนมัติ ผลวิเคราะห์และร่างเอกสารทุกฉบับต้องผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจก่อนนำไปใช้ในการดำเนินงาน

เพื่อให้การนำระบบไปใช้จริงมีมาตรฐานเดียวกัน จึงจำเป็นต้องกำหนดกระบวนการงาน บทบาทผู้ใช้งาน มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มาตรฐานการจัดการพยานหลักฐานดิจิทัล เกณฑ์ทดสอบและรับรองระบบ ตลอดจนแผนบำรุงรักษาและติดตามผลอย่างชัดเจน

3. วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาระบบสืบค้นและวิเคราะห์ความเชื่อมโยงพยานหลักฐานดิจิทัล รวมถึงช่วยจัดทำร่างแบบฟอร์มและเอกสารทางกฎหมาย
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสืบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน และบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อกำหนดมาตรฐานการรวบรวม เก็บรักษา ส่งมอบ ตรวจสอบ และส่งออกพยานหลักฐานดิจิทัลให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดวงจรชีวิตของหลักฐาน
4. เพื่อจัดให้มีการควบคุมสิทธิการเข้าถึง การบันทึกประวัติการใช้งาน การสำรองและกู้คืนข้อมูล และมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยง
5. เพื่อทดลองใช้และประเมินประสิทธิผลของระบบก่อนขยายผล โดยให้คณะทำงานด้านกฎหมายตรวจสอบผลวิเคราะห์ทุกกรณีในระย่นำร่อง

4. กลุ่มเป้าหมาย

6. คณะทำงานออกแบบ พัฒนา และกำกับดูแลระบบ LawiRisk-SSK Evidence Intelligence จำนวน 30 คน
7. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคระดับโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 50 คน
8. คณะทำงานด้านกฎหมายและการดำเนินคดีผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ศรีสะเกษ จำนวน 10 คน
9. อสม. เขียวชาญงานคุ้มครองผู้บริโภคและเครือข่ายภาคประชาชน จำนวน 30 คน โดยได้รับการอบรมเฉพาะการแจ้งเบาะแส การเก็บข้อมูลเบื้องต้น และการให้บริการสำหรับประชาชน ไม่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

5. ขอบเขตและคุณลักษณะขั้นต่ำของระบบ

10. ระบบรับและบริหารเรื่องร้องเรียนหรือสำนวนคดี โดยกำหนดเลขอ้างอิง สถานะ ผู้รับผิดชอบ และลำดับเหตุการณ์ของแต่ละเรื่อง
11. ระบบจัดเก็บพยานหลักฐานต้นฉบับโดยไม่แก้ไข พร้อมบันทึกผู้เก็บ วันเวลา แหล่งที่มา URL ข้อมูลกำกับ และค่าแฮช SHA-256 หรือวิธีการอื่นที่มีความน่าเชื่อถือเทียบเท่า
12. ระบบบันทึกประวัติการครอบครองและการดำเนินการต่อหลักฐาน (Chain of Custody) รวมถึงการรับส่ง เปิดดู ดาวน์โหลด ส่งออก และการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประกอบ
13. ระบบวิเคราะห์และแสดงความเชื่อมโยงระหว่างบุคคล เพจ หมายเลขโทรศัพท์ บัญชีธนาคาร ที่อยู่ ผู้ให้บริการขนส่ง หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยทุกจุดเชื่อมโยงต้องย้อนกลับไปตรวจสอบหลักฐานต้นทางได้
14. ระบบช่วยจัดทำร่างแบบฟอร์มหรือเอกสารทางกฎหมายจากข้อมูลที่เจ้าหน้าที่เลือก โดยแสดงแหล่งข้อมูลและสถานะว่าเป็นร่างรอตรวจสอบ

15. ระบบกำหนดสิทธิตามบทบาทและรายคดี แยกอย่างน้อยเป็นผู้รับเรื่อง ผู้สืบสวน ผู้ตรวจทานด้านกฎหมาย ผู้อนุมัติ และผู้ดูแลระบบ
16. ระบบบันทึกเหตุการณ์การใช้งาน (Audit Log) สืบรองข้อมูล ทดสอบการกู้คืน และแจ้งเตือนเหตุผิดปกติที่สำคัญ
17. ระบบต้องแยกข้อมูลบริการประชาชนออกจากข้อมูลส่วนบุคคล และไม่เปิดเผยข้อมูลคดีหรือข้อมูลส่วนบุคคลแก่ อสม. เครือข่าย หรือบุคคลที่ไม่มีอำนาจหน้าที่

6. วิธีดำเนินการ

18. แต่งตั้งคณะทำงานด้านบริหารโครงการ ด้านกฎหมาย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และตัวแทนผู้ใช้งาน พร้อมกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละงาน
19. ประชุมคณะทำงานเพื่อวิเคราะห์กระบวนการ กำหนดความต้องการ พจนานุกรมข้อมูล แบบฟอร์มทางกฎหมาย ระดับสิทธิผู้ใช้ และเกณฑ์รับมอบระบบ จำนวน 1 ครั้ง ผู้เข้าร่วม 20 คน
20. จัดทำมาตรฐานวิธีปฏิบัติงาน (SOP) สำหรับการรวบรวมพยานหลักฐานดิจิทัล การคำนวณค่าแฮช การจัดทำ Chain of Custody การตรวจทานผลวิเคราะห์ และการส่งออกชุดหลักฐาน
21. ประเมินความเสี่ยงด้านข้อมูลส่วนบุคคลและความมั่นคงปลอดภัย จัดทำรายการกิจกรรมประมวลผลข้อมูล กำหนดระยะเวลาเก็บรักษาและทำลายข้อมูล รวมถึงแผนรับมือเหตุละเมิดหรือระบบขัดข้อง
22. ปรับปรุงระบบและทดสอบด้วยข้อมูลจำลองหรือข้อมูลที่ปกปิดตัวบุคคล ก่อนใช้ข้อมูลจริง พร้อมทดสอบการควบคุมสิทธิ Audit Log การสืบรองและกู้คืนข้อมูล
23. ทดสอบการยอมรับโดยผู้ใช้ (UAT) กับกรณีศึกษาหรือเรื่องร้องเรียนไม่น้อยกว่า 20 เรื่อง โดยคณะทำงานด้านกฎหมายตรวจสอบผลทุกกรณี และแก้ไขข้อบกพร่องระดับร้ายแรงก่อนเปิดใช้งาน
24. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจำนวน 1 ครั้ง รวม 120 คน โดยแบ่งเนื้อหาเป็นหลักสูตรเจ้าหน้าที่ 90 คน และหลักสูตร อสม./เครือข่ายภาคประชาชน 30 คน
25. เปิดใช้งานนำร่อง ติดตามสถิติการใช้งาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน ความถูกต้องของผลวิเคราะห์ เหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย และข้อเสนอแนะของผู้ใช้ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน
26. สรุปผลการดำเนินงานและเสนอผู้บริหารพิจารณาการขยายผลหรือปรับปรุงระบบในระยะต่อไป

7. สถานที่ดำเนินการ

ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ และระบบประชุมออนไลน์ของหน่วยงาน การทดสอบและใช้งานระบบให้ดำเนินการผ่านอุปกรณ์และเครือข่ายที่หน่วยงานอนุญาต โดยหลีกเลี่ยงการจัดเก็บพยานหลักฐานลงในอุปกรณ์ส่วนบุคคล

8. ระยะเวลาดำเนินการ

เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2569 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2569 โดยกิจกรรมที่มีการเบิกจ่ายจากงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2569 ให้ดำเนินการภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2569 ส่วนการติดตามผลตั้งแต่เดือนตุลาคม

ถึงชั้นวาคม พ.ศ. 2569 ให้ใช้ทรัพยากรประจำของหน่วยงานและดำเนินการตามความเห็นชอบของฝ่ายการเงิน

ช่วงเวลา	กิจกรรมสำคัญ
สิงหาคม 2569	แต่งตั้งคณะทำงาน วิเคราะห์กระบวนการ จัดทำข้อกำหนดข้อมูลและสิทธิผู้ใช้
สิงหาคม-กันยายน 2569	ปรับปรุงระบบ จัดทำคู่มือและมาตรฐานการจัดการพยานหลักฐาน ทดสอบระบบและความปลอดภัย
กันยายน 2569	ทดสอบการยอมรับโดยผู้ใช้ (UAT) อบรม และเปิดใช้งานนำร่อง
ตุลาคม-ธันวาคม 2569	ติดตามผล ประเมินตัวชี้วัด แก้ไขข้อบกพร่อง และจัดทำรายงาน โดยใช้ทรัพยากรประจำของหน่วยงาน

9. งบประมาณ

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเบิกจากงบประมาณโครงการพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22,600 บาท (สองหมื่นสองพันหก ร้อย บาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน (บาท)
1	กิจกรรมประชุมคณะทำงานกำหนดความต้องการและทบทวนระบบ (1 ครั้ง 20 คน)	2,800
1.1	ค่าอาหารกลางวัน (20 คน x 80 บาท x 1 มื้อ)	1,600
1.2	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (20 คน x 30 บาท x 2 มื้อ)	1,200
2	กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบ (1 ครั้ง 120 คน)	19,800
2.1	ค่าอาหารกลางวัน (120 คน x 80 บาท x 1 มื้อ)	9,600
2.2	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (120 คน x 30 บาท x 1 มื้อ)	3,600
2.3	ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยายหลัก (2 คน x 600 บาท x 3 ชั่วโมง)	3,600
2.4	ค่าพาหนะจ่ายจริงสำหรับ อสม./เครือข่ายภาคประชาชน (30 คน x 100 บาท)	3,000
	รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น	22,600

การวิเคราะห์ ออกแบบ ปรับปรุง ทดสอบ และดูแลระบบดำเนินการโดยบุคลากรของหน่วยงานหรือทรัพยากรที่หน่วยงานมีอยู่เดิม โดยไม่เบิกค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากโครงการนี้ หากมีค่าใช้จ่ายบริการภายนอก ค่าโครงสร้างพื้นฐาน หรือค่าบำรุงรักษาเพิ่มเติม ให้เสนอขออนุมัติและดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องของแยกต่างหาก

หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ตามที่จ่ายจริง โดยไม่เกินอัตราตามระเบียบของทางราชการ และอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

10. การประเมินผล

10.1 ตัวชี้วัดโครงการ

27. มีระบบ LawiRisk-SSK Evidence Intelligence ที่สามารถจัดเก็บ สืบค้น วิเคราะห์ และแสดงความเชื่อมโยงของพยานหลักฐานดิจิทัลได้
28. กรณีทดสอบสำคัญผ่านเกณฑ์ร้อยละ 100 และไม่มีข้อบกพร่องหรือช่องโหว่ระดับร้ายแรงที่ยังไม่ได้แก้ไขก่อนเปิดใช้งาน
29. พยานหลักฐานในกรณีทดสอบมีแหล่งที่มา วันเวลา ผู้เก็บ ค่าแฮช และประวัติ Chain of Custody ครบถ้วนร้อยละ 100
30. ความแม่นยำและความครอบคลุมของการแสดงจุดเชื่อมโยงเป็นไปตามเกณฑ์ที่คณะทำงานกำหนดก่อนทดสอบ โดยเสนอเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ในชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องขบวนการรับรอง
31. ระยะเวลามีมาตรฐานในการสืบค้น วิเคราะห์ และจัดทำร่างเอกสารลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 หรือเหลือไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อเรื่อง
32. ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีคะแนนหลังอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
33. ผู้ได้รับสิทธิใช้งานอย่างน้อยร้อยละ 80 มีการเข้าใช้งานจริงภายใน 3 เดือนหลังเปิดใช้
34. ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลคดีแก่ผู้ไม่มีอำนาจ และเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยที่เกิดขึ้นได้รับการบันทึก ตรวจสอบ และดำเนินการตามแผนตอบสนองร้อยละ 100

10.2 เครื่องมือและวิธีการประเมินผล

35. แบบทดสอบก่อนและหลังการอบรมสำหรับผู้ใช้งานแต่ละบทบาท
36. แบบบันทึกเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติงานก่อนและหลังใช้ระบบ
37. ชุดกรณีทดสอบที่คณะทำงานด้านกฎหมายรับรอง พร้อมแบบตรวจความถูกต้องและความครอบคลุมของจุดเชื่อมโยง
38. รายงาน UAT รายงานการทดสอบสิทธิผู้ใช้ รายงานช่องโหว่ และหลักฐานการแก้ไข
39. รายงาน Audit Log สถิติการเข้าใช้งาน รายงานเหตุผิดปกติ และผลการทดสอบการกู้คืนข้อมูล
40. แบบประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ อสม. และเครือข่ายตามขอบเขตที่แต่ละกลุ่มได้รับอนุญาต

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

11.1 เชิงผลผลิต (Output)

41. ได้ระบบ LawiRisk-SSK Evidence Intelligence สำหรับสืบค้น วิเคราะห์ความเชื่อมโยง และบริหารจัดการพยานหลักฐานดิจิทัล
42. ได้มาตรฐานวิธีปฏิบัติงาน คู่มือผู้ใช้ คู่มือผู้ดูแลระบบ แบบฟอร์ม Chain of Custody และเกณฑ์ตรวจรับระบบ
43. มีเจ้าหน้าที่และเครือข่ายผ่านการอบรมตามบทบาทและขอบเขตสิทธิที่กำหนด

11.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)

44. กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคสามารถจัดการพยานหลักฐานของเรื่องร้องเรียนและเชื่อมโยงข้อมูลข้ามคดีได้รวดเร็วและตรวจสอบย้อนกลับได้
45. พนักงานเจ้าหน้าที่ลดเวลางานเข้าชั้นและมีข้อมูลประกอบการพิจารณาที่เป็นระบบ โดยยังคงเป็นผู้รับผิดชอบการวินิจฉัยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
46. ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองจากการเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายที่รวดเร็วขึ้น โดยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลคดีได้รับการป้องกันตามสิทธิและความจำเป็น

12. การกำกับดูแลข้อมูล กฎหมาย และความมั่นคงปลอดภัย

47. กำหนดให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษเป็นเจ้าของระบบและผู้ควบคุมข้อมูลตามบทบาทหน้าที่ โดยมอบหมายผู้ดูแลระบบ ผู้รับผิดชอบข้อมูล ผู้ตรวจทานด้านกฎหมาย และผู้ประสานงานด้านคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นลายลักษณ์อักษร
48. จัดทำรายการกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล กำหนดวัตถุประสงค์และฐานการประมวลผล ประเภทข้อมูล ผู้รับข้อมูล ระยะเวลาเก็บรักษา มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย และช่องทางใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล
49. ใช้หลักการให้สิทธิเท่าที่จำเป็นต่อหน้าที่ ทบทวนสิทธิเป็นระยะ และเพิกถอนสิทธิทันทีเมื่อพ้นหน้าที่หรือยุติการปฏิบัติงาน
50. เก็บต้นฉบับพยานหลักฐานแยกจากข้อมูลที่ระบบสร้างขึ้น ห้ามเขียนทับต้นฉบับ และให้ตรวจสอบค่าแฮชก่อนส่งมอบหรือส่งออกหลักฐาน
51. ผลวิเคราะห์ของระบบต้องแสดงแหล่งข้อมูลและข้อจำกัด ห้ามนำผลที่ระบบสร้างขึ้นไปใช้กล่าวหาหรือดำเนินคดีโดยไม่มีการตรวจสอบจากพนักงานเจ้าหน้าที่
52. จัดทำแผนสำรองและกู้คืนข้อมูล แผนรับมือเหตุละเมิดข้อมูลหรือระบบถูกโจมตี และช่องทางรายงานเหตุแก่ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบความมั่นคงปลอดภัย และผู้เกี่ยวข้อง
53. ทบทวนให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวข้อง และแนวทางธรรมาภิบาลปัญญาประดิษฐ์ที่หน่วยงานกำหนด

13. แผนบำรุงรักษาและความต่อเนื่อง

54. มอบหมายผู้ดูแลระบบหลักและผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน พร้อมกำหนดช่องทางแจ้งปัญหาและระยะเวลาตอบสนองตามระดับความรุนแรง

55. สำรองข้อมูลตามรอบที่กำหนดและทดสอบการกู้คืนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระบบที่สำคัญ
56. ติดตามข้อผิดพลาด ช่องโหว่ และความถูกต้องของผลวิเคราะห์ พร้อมบันทึกเวอร์ชันและการเปลี่ยนแปลงของระบบ
57. ทบทวนแบบฟอร์ม ฐานกฎหมาย แหล่งข้อมูล และสิทธิผู้ใช้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อกฎหมายหรือกระบวนการเปลี่ยนแปลง
58. จัดทำแผนส่งออกข้อมูลและย้ายระบบเพื่อป้องกันการผูกติดกับผู้ให้บริการรายเดียว และให้หน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลและรหัสต้นฉบับที่จำเป็นต่อการดำเนินงานต่อเนื่อง

14. ผู้รับผิดชอบโครงการ

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

คณะทำงานกำกับดูแลระบบ LawiRisk-SSK Evidence Intelligence ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนด้านกฎหมาย เทคโนโลยีสารสนเทศ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และผู้ใช้งานระบบ

15. เอกสารประกอบที่ต้องจัดทำก่อนเปิดใช้ข้อมูลจริง

59. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานและตารางกำหนดผู้รับผิดชอบ (RACI)
60. ขอบเขตความต้องการและเกณฑ์ตรวจรับระบบ
61. พจนานุกรมข้อมูลและตารางสิทธิผู้ใช้
62. SOP การจัดการพยานหลักฐานดิจิทัลและแบบฟอร์ม Chain of Custody
63. รายการกิจกรรมประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ประกาศความเป็นส่วนตัว และตารางระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูล
64. รายงาน UAT รายงานทดสอบความมั่นคงปลอดภัย และหลักฐานการแก้ไขข้อบกพร่อง
65. แผนสำรองและกู้คืนข้อมูล แผนรับมือเหตุผิดปกติ และแผนบำรุงรักษา
66. คู่มือผู้ใช้ คู่มือผู้ดูแลระบบ และหลักฐานการฝึกอบรม

การลงนาม

(ลงชื่อ) ผู้เสนอโครงการ

(นศ.ภ. จตุพร เรืองวิไลกฤตย์)

นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 6

(ลงชื่อ) ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวมัลลิกา สุลล)

เภสัชกรชำนาญการ

(ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายไพฑูรย์ แก้วอมร)

เภสัชกรเชี่ยวชาญ

(รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ)

(ลงชื่อ) ผู้อนุมัติโครงการ

(นายทอง วีระแสงพงษ์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ